BikeRc

Raport rehabilitacji stopy

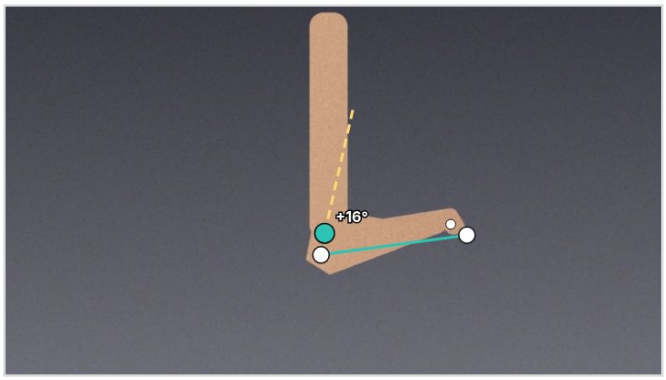
Pomiar zakresu ruchu stawu skokowego (kostki) z filmu lub kamery

PACJENT	DATA POMIARU	STRONA
—	01.11.2026 21:57	prawa (po urazie)
ŹRÓDŁO	**CZAS / KLATKI**	**HISTORIA**
film: s_land.mp4	6.9 s · 84 próbek	1 pomiarów (1 dni)

KLUCZOWE WYNIKI TEGO POMIARU

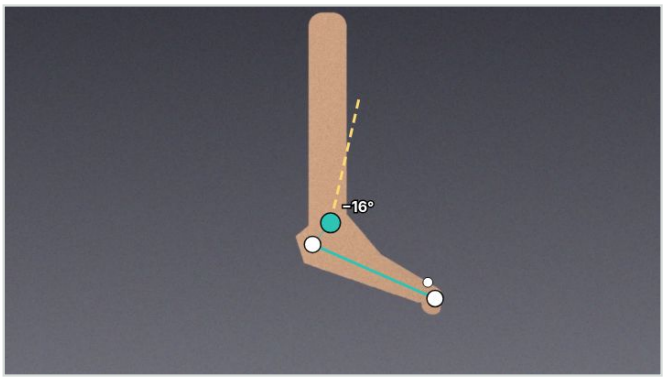
MAKS. ZGIĘCIE GRZBIETOWE	MAKS. ZGIĘCIE PODESZWOWE	ZAKRES RUCHU	POWTÓRZENIA
+15°	**−16°**	**31°**	**3**
orient. ok. +20°	orient. −40...−50°	−16° ... +15°	w 7 s

KLATKI Z TEGO FILMU – SKRAJNE POŁOŻENIA STOPY



Maks. zgięcie grzbietowe: +16°

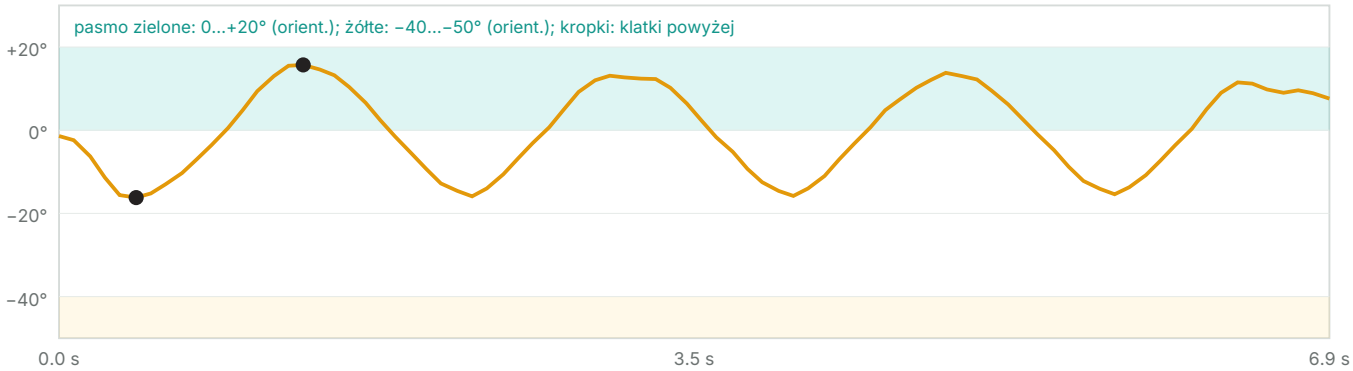
klatka z 1.3 s filmu



Maks. zgięcie podeszwowe: −16°

klatka z 0.4 s filmu

KĄT KOSTKI W CZASIE (+ GRZBIETOWE, – PODESZWOWE)



OBSERWACJE AUTOMATYCZNE (ORIENTACYJNE)

- Maksymalne zgięcie grzbietowe w tym pomiarze: +15° (orientacyjnie dla zdrowej kostki ok. 20°).
- Maksymalne zgięcie podeszwowe: −16° (orientacyjnie 40–50°). Całkowity zakres ruchu: 31° (orientacyjnie 60–70°). Wykonano powtórzeń: 3.

Wartości orientacyjne, generowane automatycznie – nie stanowią diagnozy medycznej. Skonsultuj ćwiczenia z fizjoterapeutą.

PORÓWNANIE: NOGA ZDROWA I PO URAZIE

Brak pomiarów obu stron – nagraj zdrową i kontuzjowaną nogę w takim samym ustawieniu kamery, aby zobaczyć porównanie.

POSTĘPY – ZAKRES RUCHU W KOLEJNYCH POMIARACH

Wykres postępów pojawi się po zapisaniu co najmniej dwóch pomiarów.

POMIARY (OD NAJNOWSZEGO)

DATA	STR.	MIN...MAX	ZAKRES	POWT.	ŹRÓDŁO
01.11.2026 21:57	P	−16...+15°	**31°**	3	film

METODYKA I ZASTRZEŻENIE

Stopę i kostkę wykrywa lokalnie w przeglądarce model RTMW-m (133 punkty ciała, w tym pięta i palce stopy), uruchamiany na kolejnych klatkach filmu; obraz nie jest nigdzie wysyłany. Kąt kostki to kąt między osią stopy (pięta–palec I) a osią goleni w płaszczyźnie obrazu (2D), względem pozycji neutralnej (stopa prostopadła do goleni = 0°): „+" oznacza zgięcie grzbietowe, „−" podeszwowe. Zakres i powtórzenia liczone są z wygładzonego przebiegu kąta. Dokładność zależy od ustawienia kamery (prostopadle do płaszczyzny ruchu), światła i widoczności stopy – pomiar nie zastępuje goniometru.

To narzędzie orientacyjne – wynik nie jest diagnozą medyczną ani oceną stanu zdrowia. Zakres i rodzaj ćwiczeń oraz decyzje dotyczące rehabilitacji należy skonsultować z fizjoterapeutą lub lekarzem prowadzącym.